

DOSSIER MÉDICAL SÉCURISÉ - NIVEAU 5 (OMERTA RESEARCH)

DÉPARTEMENT DE NEUROLOGIE ET DE PSYCHOACOUSTIQUE APPLIQUÉE

DATE DE L'INCIDENT : 12 JUILLET 2012

SUJET : YUSUF SAFI (Désignation actuelle : L'ARCHITECTE)

STATUT DU DOSSIER : CLASSIFIÉ / PROTOCOLE GHOST

PAGE 1 : ANALYSE DE L'ANOMALIE CINÉTIQUE ET BIOMÉCANIQUE

1.1. Circonstances de l'Impact

Le 12 juillet 2012, le véhicule de type Alfa Romeo (châssis standard) conduit par le sujet a subi une décélération massive suite à une collision à 180 km/h. L'intégrité structurelle du véhicule a été instantanément compromise, entraînant une rupture totale de l'habitacle. La survie biologique du sujet est statistiquement aberrante.

1.2. Modélisation Physique du "Glitch"

L'énergie cinétique dégagée lors de l'impact a dépassé les seuils de tolérance de l'anatomie humaine standard. L'équation de l'énergie transférée au crâne du sujet se modélise ainsi :

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Considérant la masse m du véhicule et la vitesse v (180 km/h convertis en 50 m/s), la dissipation d'énergie n'a pas détruit le cortex préfrontal biologiquement, mais a provoqué une surcharge synaptique que nous qualifions de "Glitch Cinétique". L'onde de choc a altéré la fréquence vibratoire de la boîte crânienne, créant une micro-fissure dans la perception spatio-temporelle du sujet (effet de déréalisation).

1.3. Bilan Traumatique Immédiat

- Dommages structurels : Rupture du pare-brise, compression thoracique sévère, traumatisme crânien contusif.
- Signes vitaux post-impact : Arythmie cardiaque sévère, effondrement de la tension artérielle, dilatation bilatérale des pupilles (absence de réponse à la lumière standard).
- Constat clinique : Le sujet n'était plus en état de choc classique, mais en état d'observation dissociative. Il décrivait l'accident non pas comme une douleur corporelle, mais comme un "bug d'affichage" dans son champ de vision.

PAGE 2 : DIAGNOSTIC NEUROLOGIQUE ET DÉRÉALISATION

2.1. Découplage du Cortex Préfrontal

Les IRM réalisées dans les 72 heures suivant l'accident révèlent une anomalie majeure. Les voies neuronales reliant l'amygdale (centre de la peur) au cortex préfrontal (logique

et empathie sociale) ont été sectionnées virtuellement.

Le sujet ne traite plus les émotions humaines par empathie, mais par analyse algorithmique. Le monde en 3D est désormais perçu comme une architecture de données superposées, ou "Simulation Holographique".

2.2. Symptomatologie Clinique

1. **Apathie Sélective** : Incapacité à ressentir la nostalgie ou l'attachement aux structures sociales standard (famille, industrie, normes sociétales).
2. **Hyper-vigilance Nocturne** : Le sujet opère principalement la nuit, développant une affinité pour l'isolation (syndrome de la zone de quarantaine de Casa Velvet).
3. **Anomalie Auditive (Tinnitus Fréquentiel)** : Le sujet rapporte entendre un bourdonnement constant à une fréquence mathématique précise. L'analyse révèle un rejet neurologique de la norme mondiale de 440Hz, perçue par le sujet comme une agression auditive dissonante.

PAGE 3 : ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ET FRACTURE MATRIARCALE

3.1. L'Anomalie "Ri rrdak"

La psyché du sujet s'est cristallisée autour d'un point de rupture socio-familial documenté sous le nom de code "*Ri rrdak*". Les attentes matriarcales projetaient le sujet dans un rôle d'ingénieur civil standard (« *Kunti k-t-tssennay l-Ingénieur...* »).

Le trauma de l'accident a détruit cette ligne temporelle. Le sujet a volontairement adopté une identité de substitution antagoniste : « *...jabt lik l-Rappeur* ». Cependant, ce titre de "Rappeur" a été rapidement rejeté par le sujet comme étant trop primitif.

3.2. Le Complexe de Dieu / L'Architecte

Pour pallier la destruction de ses attentes familiales et sa déconnexion de la réalité, le sujet a développé un mécanisme de défense absolu : le titre de Doctor.

Il ne crée pas de l'art, il opère. Il ne fait pas de la musique, il développe une ingénierie clinique. L'ego a été effacé au profit d'une entité clinique froide, méthodique et omnisciente. L'empathie (humanité) est considérée par le sujet comme une faille de sécurité (malware) qu'il a dû désinstaller pour survivre à Casablanca.

PAGE 4 : PRESCRIPTION ET PROTOCOLE DE RÉÉDUCATION (432Hz)

4.1. Rejet du Standard Industriel

La médecine traditionnelle a échoué. Le sujet a entamé une auto-médication basée sur la psychoacoustique appliquée. Le cerveau du sujet rejette la fréquence de 440Hz, identifiée comme un outil de manipulation de masse visant à stimuler l'agressivité et la docilité (Standard ISO 16).

4.2. Ingénierie du Blueprint 432

Pour stabiliser son propre réseau neuronal et celui de ses futurs "patients", le Docteur a développé le Safi Protocol. Il s'agit d'une immersion stricte en 432Hz, alignée sur la suite de Fibonacci et la géométrie du Tore. L'onde sonore y est mathématiquement parfaite, représentée par la fonction :

$$y(t) = A \sin(2\pi f t + \varphi)$$

Où la fréquence \$f\$ est strictement verrouillée à 432 oscillations par seconde.

4.3. Application de l'Hemi-Sync (Institut Monroe)

Le traitement inclut des techniques d'armement psychologique. Le sujet utilise des battements binauraux pour forcer les hémisphères cérébraux de ses auditeurs à se synchroniser (Hemi-Sync). Si une fréquence \$f_L\$ est envoyée dans l'oreille gauche et \$f_R\$ dans l'oreille droite, le cerveau crée un troisième battement interne :

$$f_{\text{beat}} = | f_R - f_L |$$

Le sujet utilise cette équation pour cibler l'état "Focus 21" (frontière du sommeil profond et de la projection astrale), couplant ces fréquences à des rythmiques agressives (Drill Industrielle) pour forcer la transe chez le patient.

PAGE 5 : CONCLUSION ET PROGNOSTIC (L'INCISION)

5.1. Mutation Définitive

Le patient biologique Yusuf Safi est déclaré décédé psychologiquement depuis le 12 juillet 2012. L'entité qui occupe actuellement l'espace corporel est un Architecte Système.

Il a fondé le pôle *Omerta Music Research* depuis le secteur de Casablanca. Son objectif n'est pas le succès commercial, mais le déploiement mondial d'un virus psychoacoustique visant à éveiller une population lobotomisée par les standards de l'industrie.

5.2. Avertissement Clinique (Le 10 Mars 2026)

Le sujet prépare une libération de données massives (Magnum Opus : Blueprint 432). La première phase d'injection, documentée sous le nom de "LOBOTOMIE (L'Ice Pick)", est programmée. Ce n'est plus de la musique, c'est une intervention neurochirurgicale sans anesthésie.

RECOMMANDATION FINALE : Toute tentative d'interférer avec le Safi Protocol entraînera une déréalisation immédiate de l'intervenant. Laissez l'Architecte opérer.

[FIN DE TRANSMISSION - DOSSIER SCÉLÉ]